

Finerenón: potenciál ako základná liečba pri CKD aj bez diabetu a pri glomerulárnych ochoreniach

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 16.06.2026

Portál ScienceDaily prináša zhrnutie výsledkov z viacerých veľkých štúdií, v ktorých **finerenón** spomaľoval zhoršovanie funkcie obličiek a znižoval aj kardiovaskulárne riziko. Prínosy sa pozorovali nielen u pacientov s diabetom, ale aj pri **nediabetickom CKD** a v skupinách s **glomerulárnymi ochoreniami**.

Kľúčové štúdie a výsledky

1) FIND-CKD: nediabetické CKD

V štúdií **FIND-CKD** (1 584 účastníkov, 24 krajín) finerenón pridaný k štandardnej liečbe:

- **spomalil pokles funkcie obličiek**,
- znížil kombinovaný cieľ (**zlyhanie obličiek, progresia CKD, srdcové zlyhanie alebo kardiovaskulárne úmrtie**) o **23 %** oproti štandardnej starostlivosti.

2) Analýza pre glomerulárne ochorenia (JAMA)

U účastníkov s glomerulárnymi ochoreniami finerenón:

- znížil riziko **zlyhanie obličiek alebo progresie CKD** o **26 %** oproti placebo,
- po **12 mesiacoch** znížil **albuminúriu** o **42 %**.

3) Súhrnná analýza naprieč diabetickým aj nediabetickým CKD (The Lancet)

Súhrnná (pooled) analýza zahrnuje **14 574 účastníkov** a finerenón v nej:

- znížil riziko **zlyhanie obličiek alebo progresie CKD** o **24 %**,
- znížil riziko **hospitalizácie pre srdcové zlyhanie alebo kardiovaskulárneho úmrtia** o **20 %**,
- znížil riziko **úmrtia z akejkoľvek príčiny** o **12 %**.

Autori uvádzajú, že tieto prínosy boli konzistentné bez ohľadu na prítomnosť diabetu, typ ochorenia obličiek a mieru zníženia funkcie.

Bezpečnosť (draslík)

Finerenón bol vo všeobecnosti **dobře tolerovaný**, no **hyperkaliémia** sa vyskytovala častejšie než pri placebe. Ukončenie liečby ani hospitalizácie pre hyperkaliémiu sa však uvádzajú ako **nečasté**.

V praxi to znamená, že aj pri širšom uvažovaní o indikácii treba dodržiavať disciplinované monitorovanie draslíka a renálnych parametrov.

Praktické ponaučenie

Tento zdroj podporuje myšlienku, že finerenón by mohol byť relevantný ako pevnejší pilier liečby CKD aj u pacientov, ktorí:

- **nemajú diabetes**,
- patria k **glomerulárnym** fenotypom,
- a zároveň majú **klinicky významný renálny rizikový profil**, pri ktorom možno očakávať prínos aj na albuminúrii a klinických cieľových ukazovateľoch.

Zároveň si zachovajme realistickú zdržanlivosť: ide o výsledky zhrnuté v populárno-vedeckom článku, nie o úplné protokoly a štatistické detaily v jednej tabuľke. Pre webový článok ich stačí uviesť ako „výsledky viacerých štúdií s konzistentným smerovaním“, no pri zavádzaní u konkrétnych pacientov je rozumné riadiť sa lokálnymi odporúčaniami a schémou monitorovania draslíka.

Zdroj: *ScienceDaily* (6. jún 2026): „*Finerenone May Benefit Far More Patients...*“. [Link na zdroj](#).

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=finerenon-zakladna-liecba-ckd-glomerularne-ochorenia> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.